

Datei: eml/2026-07-06_/rentenrecht-erwerbsminderung-long-covid-pots-koeln.eml

Von	Ralf Mertens <ralf.mertens@kliniken-koeln.example>
An	Jana Frings <j.fring@rentenberatung-frings.example>
Datum	Mon, 06 Jul 2026 09:18:00 +0200
Betreff	RF-26-204 / Zeiterfassung Arbeitsplatzversuch Frau Renneberg

Sehr geehrte Frau Frings,

Frau Renneberg hat uns gestattet, die Anwesenheitszeiten aus dem Arbeitsplatzversuch an Sie zu übermitteln. Die beigefügte Bescheinigung enthält die sechs dokumentierten Termine. Zusätzlich gibt es Einträge im elektronischen Zutrittssystem; diese kann unsere Personalabteilung nach Freigabe als Liste ausgeben.

Zur Einordnung: Frau Renneberg war bei den ausgeführten Aufgaben fachlich sicher. Der Versuch scheiterte nicht an Fehlern oder fehlender Motivation, sondern daran, dass Anwesenheit, Pausen und kurzfristige Ausfälle nicht planbar waren. Ein dauerhaftes Einzelbüro ohne Telefon und Laufwege steht im Zentral-OP nicht zur Verfügung.

Bitte teilen Sie Frau Schöning in Kopie mit, ob Sie die Zutrittsliste benötigen. Wir benötigen dafür etwa drei Arbeitstage.

Mit freundlichen Grüßen

Ralf Mertens
Leitung Zentral-OP
Kliniken der Stadt Köln gGmbH
Ostmerheimer Straße 200 · 51109 Köln
Telefon 0221 8907-4412

Datei: eml/2026-07-06_sachstand_nachforderung.eml

Von	Jana Frings <j.fring@rentenberatung-frings.example>
An	Saskia Renneberg <saskia.renneberg@example.org>
Datum	Mon, 06 Jul 2026 16:24:00 +0200
Betreff	RF-26-204 / Unterlagen für die Widerspruchsbegründung

Sehr geehrte Frau Renneberg,

der Widerspruch ist fristgerecht abgesandt. Bitte reichen Sie bis Freitag, 10. Juli, noch folgende Unterlagen ein:

1. die Zeiterfassung oder Kalendereinträge zum Arbeitsplatzversuch im Mai,
2. die Bildschirmfotos der Pulsuhr zu den im Belastungstagebuch genannten Tagen,
3. die Krankengeldbescheinigung für März bis Juni 2026,
4. den vollständigen Medikamentenplan mit Datum der Ivabradin-Einnahme.

Bitte erstellen Sie keine neue zusammenfassende Krankengeschichte. Die vorhandenen zeitnahen Notizen sind hilfreicher. Originale können Sie am Empfang abgeben; wir scannen sie und geben sie sofort zurück.

Sobald die Verwaltungsakte eingegangen ist, vereinbaren wir einen Termin zur Begründung. Bis dahin muss keine zusätzliche Stellungnahme an die Rentenversicherung geschickt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Jana Frings
Rentenberaterin
Hohenzollernring 57 · 50672 Köln
Telefon 0221 29917-0
Aktenzeichen RF-26-204

Datei: 91_fristsachen_belege_offene_punkte_2026-07-06.csv

Vorgang

Ablehnungsbescheid

Zugang oder Termin

2026-06-24

Frist

2026-07-24

Vorfrist

2026-07-17

Beleg

Bescheid und Umschlag

Status

Widerspruch am 01.07. versandt

Nächster Schritt

Eingangsbestätigung kontrollieren

Vorgang

Akteneinsicht

Zugang oder Termin

2026-07-01

Frist

2026-07-15

Vorfrist

2026-07-12

Beleg

Widerspruchsschreiben

Status

offen

Nächster Schritt

sozialmedizinische Stellungnahme nachfassen

Vorgang

Arbeitsplatzversuch

Zugang oder Termin

2026-06-04

Frist

2026-07-10

Vorfrist

2026-07-08

Beleg

Arbeitgeberbescheinigung

Status

Zeiterfassung fehlt

Nächster Schritt

Personalservice kontaktieren

Vorgang

Kipptisch

Zugang oder Termin

2026-05-21

Frist

2026-07-10

Vorfrist

2026-07-08

Beleg

Kurzbefund

Status

vollständig

Nächster Schritt

Original zur Akte nehmen

Vorgang

Krankengeld

Zugang oder Termin

2026-06-30

Frist

2026-07-14

Vorfrist

2026-07-10

Beleg

Kontoauszüge

Status

Bescheinigung März fehlt

Nächster Schritt

Krankenkasse anschreiben

Vorgang

Widerspruchsbegründung

Zugang oder Termin

nach Akteneinsicht

Frist

vier Wochen nach Eingang

Vorfrist

zwei Wochen vorher

Beleg

Gesamtakte

Status

noch nicht laufend

Nächster Schritt

mehrtägige Belastbarkeit herausarbeiten

Datum	Beginn	Belastung	Dauer Minuten	Maximalpu ls	unmittelba re Beschw erden	Erholungs zeit Stunden	Folgetag	Beleg
2026-06-01	09:20	Duschen und Haare waschen	24	116	Beinschwäche	1.5	vormittags eingeschränkt	Kalendernotiz
2026-06-03	10:10	Arztweg und Wartezeit	78	138	Schwindel und Zittern	5.5	Elternabend abgesagt	Terminzettel
2026-06-05	11:00	Telefonat Krankenkasse	31	104	Konzentrationsabfall	1.0	keine besondere Verschlechterung	Anrufliste
2026-06-08	09:35	Wäsche sortieren im Sitzen	38	112	Kopfdruck	2.0	später Start	Notiz Tobias
2026-06-10	08:40	Untersuchung Rentenversicherung	94	151	Übelkeit und Brain Fog	6.0	überwiegend Bettruhe	Einladung und Pulsuhr
2026-06-14	14:10	Besuch der Mutter	65	109	Reizüberlastung	3.0	Ruhetag	Familienkalender
2026-06-19	10:30	Supermarkt mit Ehemann	25	129	zweimaliges Hinsetzen	6.0	vormittags nicht belastbar	Kassenbon
2026-06-21	12:00	Mittagessen vorbereitet	42	118	Tremor und Wortfindung	2.5	leicht verschlechtert	Notiz
2026-06-24	09:15	E-Mails in drei Blöcken	52	101	Fehler beim Kochen danach	4.0	Kopfschmerz	Entwürfe gespeichert
2026-06-27	16:00	Spaziergang 420 Meter	18	134	Kurzatmigkeit	3.5	lange Schlafphase	Pulsuhr
2026-06-30	10:00	Besprechung Protokoll	47	106	Konzentration lässt nach	1.5	noch offen	Notiz Rentenberatung

Tabellenblatt: Zeiten

Beginn	Ende	Tatbestand	Meldung DRV	Nachweis	Klärungsbedarf	zuständig
2006-09-01	2017-02-28	Pflichtbeiträge Klinikum	gespeichert	Arbeitgebermeldung	keiner	DRV
2017-03-01	2017-06-30	Mutterschutz	gespeichert	Kassenmeldung	Monate abgleichen	Frings
2017-07-01	2020-06-30	Kindererziehungszeit	teilweise	Geburtsurkunde Nele	Zuordnung März 2018 fehlt	DRV
2018-03-01	2024-11-30	Beschäftigung Klinikum	gespeichert	Lohnkonto	Überlappung Kinderzeit prüfen	Frings
2024-12-01	2025-01-12	Entgeltfortzahlung	gespeichert	Abrechnung	keiner	Klinikum
2025-01-13	2026-03-31	Krankengeld	bis Februar gespeichert	Kassenbescheinigung	Märzmeldung fehlt	Krankenkasse
2026-04-06	2026-05-04	medizinische Rehabilitation	gemeldet	Entlassungsbericht	Übergangsgeldbescheid fehlt	DRV
2026-05-05	laufend	Krankengeld	offen	Kontoauszüge	Leistungsbescheinigung anfordern	Krankenkasse

Tabellenblatt: Medizin

Datum	Unterlage	Aussage	Original vorhanden	Offener Punkt
2026-05-09	Reha-Entlassungsbericht	drei bis unter sechs Stunden mit engen Bedingungen	ja	vollständige Therapieanwesenheit anfordern
2026-05-21	Kipptischprotokoll	Herzfrequenzanstieg und Präsynkope	ja	Medikationspause dokumentiert
2026-06-04	Arbeitgeberbescheinigung	Versuch organisatorisch gescheitert	ja	Zeiterfassung beifügen
2026-06-10	DRV-Untersuchung	noch nicht in Akte	nein	Akteneinsicht
2026-06-30	Alltagsprotokoll	Schwankung und Folgetage	ja	Pulsbilder sichern

Datei

Office-Dokument: 01_antrag_erwerbsminderungsrente_2026-03-11.docx

Rentenberatung Frings · Hohenzollernring 57 · 50672 Köln

Deutsche Rentenversicherung Bund
Leistungsabteilung 7
Ruhrstraße 2
10709 Berlin

Datum	11. März 2026
Aktenzeichen	RF-26-204 · VSNR 53 170885 R 214
Bearbeitung	Jana Frings

Antrag auf Rente wegen Erwerbsminderung für Saskia Renneberg

Sehr geehrte Damen und Herren,

1. Antrag

Namens und in Vollmacht von Frau Saskia Renneberg, geboren am 17. August 1985, Aachener Straße 418, 50933 Köln, beantrage ich Rente wegen voller Erwerbsminderung, hilfsweise Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung. Der Antrag soll auf den 11. März 2026 wirken. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe am Arbeitsleben sind in die Prüfung einzubeziehen.

2. Beruflicher Verlauf

Frau Renneberg ist examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und war seit September 2006 im Klinikum Köln-Merheim beschäftigt, seit 2012 im Zentral-OP. Ihre Tätigkeit umfasste Instrumentieren, sterile Vorbereitung, Materialkontrolle, Lagerungshilfe, Dokumentation und wechselnde Bereitschaftsdienste. Seit der Infektion im November 2024 besteht durchgehend Arbeitsunfähigkeit mit zwei erfolglosen Wiedereingliederungsversuchen.

Der Arbeitgeber bot ab April 2026 probeweise Verwaltungsaufgaben im OP-Büro an. Die Akte enthält hierzu noch keine abschließende Arbeitgeberbescheinigung. Nach telefonischer Vorabinformation waren längere Konzentrationsblöcke, ungeplante Laufwege und Geräuschspitzen nicht durchhaltbar.

3. Gesundheitliche Einschränkungen

Behandlungsseitig werden ein postinfektiöses Syndrom mit ausgeprägter Belastungsintoleranz, posturales Tachykardiesyndrom, wiederkehrende Präsynkopen, kognitive Verlangsamung und nicht erholsamer Schlaf beschrieben. Belastungen von 45 bis 90 Minuten führen nach den Aufzeichnungen häufig zu einer Verschlechterung am Folgetag. Die Schwankungen sind nicht mit einem regelmäßigen Wochenplan vereinbar.

Frau Renneberg kann an guten Vormittagen kurze Gespräche führen und einzelne Wege erledigen. Daraus lässt sich nach ihrer Darstellung keine verlässliche tägliche Belastbarkeit ableiten. Sie benötigt nach Duschen oder einem Arztweg wiederholt mehrstündige Ruhe. Einkäufe übernimmt überwiegend ihr Ehemann.

4. Versicherungsrechtlicher Verlauf

Zeitraum	Status	Nachweis
09/2006 bis 02/2017	Pflichtbeiträge Klinikum	Versicherungsverlauf und Lohnkonto
03/2017 bis 02/2018	Mutterschutz und Kindererziehungszeit	Geburtsurkunde Tochter Nele
03/2018 bis 11/2024	Pflichtbeiträge Klinikum	Arbeitgebermeldung
12/2024 bis laufend	Entgeltfortzahlung, Krankengeld, Reha	Kassenbescheinigung teilweise

Rentenberatung Frings

Hohenzollernring 57 · 50672 Köln

Telefon 0221 29917-0 · Telefax 0221 29917-29 · post@rentenberatung-frings.example

Rentenberaterin Jana Frings · Registriert im Rechtsdienstleistungsregister

Zeitraum	Status	Nachweis
		vorhanden

5. Anlagen

Beigefügt sind Vollmacht, Versicherungsverlauf vom 4. Februar 2026, Befundbericht der hausärztlichen Praxis, Zwischenbericht der Post-Covid-Ambulanz, Arbeitsunfähigkeitsübersicht und Krankengeldbescheinigung. Der Reha-Entlassungsbericht wird nachgereicht, sobald er vorliegt.

Bitte bestätigen Sie den Eingang und teilen Sie mit, welche Formulare oder Befundberichte noch benötigt werden.

Jana Frings

Rentenberaterin

Datei

Office-Dokument: 02_reha_entlassungsbericht_auszug_2026-05-09.docx

Datum

9. Mai 2026

Aktenzeichen

Fall 26-4118 · VSNR 53 170885 R 214

Bearbeitung

Dr. med. Jens Mörsch · Dr. med. Amelie Reuter

Stationäre Rehabilitation vom 6. April bis 4. Mai 2026

1. Diagnosen

Postinfektiöses Syndrom nach SARS-CoV-2-Infektion im November 2024 mit Fatigue, Belastungsintoleranz und kognitiver Verlangsamung. Posturales Tachykardiesyndrom mit dokumentiertem Herzfrequenzanstieg im Stehen. Rezidivierende Präsynkopen ohne Bewusstseinsverlust. Anpassungsstörung mit Sorge um Arbeitsplatz und Existenz, derzeit ohne Hinweis auf eine primäre schwere depressive Episode.

2. Aufnahmebefund

Bei Aufnahme war Frau Renneberg im Gespräch wach, orientiert und gut auskunftsfähig. Der Ruhepuls lag bei 82 pro Minute, nach zehn Minuten Stehen bei 137 pro Minute. Der Sechs-Minuten-Gehtest wurde nach 218 Metern wegen Schwindel und Beinschwäche unterbrochen. Nach dem Test lag die Patientin 46 Minuten im Ruheraum. Am Folgetag nahm sie wegen verstärkter Fatigue nur an einem von drei Therapieangeboten teil.

3. Therapieverlauf

Erprobt wurden Kreislauftraining in Rückenlage, Kompressionsversorgung, Pacing, Ergotherapie und kognitive Belastungssteuerung. Eine lineare Belastungssteigerung gelang nicht. An zwölf Behandlungstagen waren reduzierte Programme erforderlich. Zwei geplante Außenbelastungen wurden abgebrochen; nach einer 75-minütigen Gruppen- und Wegeeinheit kam es zu einem zweitägigen Einbruch mit überwiegender Bettruhe.

Die Patientin arbeitete zuverlässig mit und führte ein nachvollziehbares Belastungsprotokoll. In ruhiger Umgebung konnte sie 30 bis 45 Minuten an einem Bildschirm arbeiten. Nach Pausen waren einzelne weitere Blöcke möglich; eine täglich wiederholbare Gesamtleistung ließ sich in der vierwöchigen Beobachtung nicht stabil herstellen.

4. Sozialmedizinische Beurteilung

Die bisherige Tätigkeit im Zentral-OP ist wegen Stehen, Zeitdruck, spontanen Laufwegen, Schichtdienst und hoher Verantwortung auf absehbare Zeit nicht leidensgerecht. Für leichte Tätigkeiten wird formal ein Leistungsvermögen von drei bis unter sechs Stunden diskutiert. Diese Einschätzung setzt jedoch frei einteilbare Pausen, geringe Reizdichte, kurze Wege und die Möglichkeit voraus, bei Kreislaufbeschwerden die Arbeit sofort zu unterbrechen.

Die beobachteten Folgetag-Ausfälle und die fehlende Planbarkeit begrenzen die praktische Verwertbarkeit. Eine erneute ambulante Verlaufskontrolle und eine genaue Arbeitsplatzbeschreibung werden empfohlen. Eine konkrete Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt wurde im Reha-Verlauf nicht erprobt.

5. Entlassung

Entlassung weiterhin arbeitsunfähig. Medikation: Ivabradin 5 mg morgens und abends, Elektrolytlösung nach Bedarf, Kompressionsstrümpfe Klasse II. Hausärztliche und kardiologische Kontrolle innerhalb von vier Wochen. Der Bericht wurde am 9. Mai 2026 elektronisch freigegeben.

Dr. med. Jens Mörsch · Dr. med. Amelie Reuter

Ärztlicher Direktor · Oberärztin Kardiologie

Datei

Office-Dokument: 03_drv_ablehnungsbescheid_2026-06-22.docx

Frau Saskia Renneberg

Aachener Straße 418

50933 Köln

Datum

22. Juni 2026

Aktenzeichen

53 170885 R 214 / 70 26 1184

Bearbeitung

Miriam Kästner

Ihr Antrag auf Rente wegen Erwerbsminderung

Sehr geehrte Frau Renneberg,

1. Entscheidung

Ihr Antrag vom 11. März 2026 auf Rente wegen Erwerbsminderung wird abgelehnt. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung liegt weder volle noch teilweise Erwerbsminderung im Sinne des Paragraphen 43 SGB VI vor.

2. Medizinische Bewertung

Wir haben den Reha-Entlassungsbericht vom 9. Mai 2026, Befundberichte der Hausärztin und der Post-Covid-Ambulanz sowie die sozialmedizinische Stellungnahme unseres ärztlichen Dienstes vom 15. Juni 2026 berücksichtigt. Danach können Sie leichte körperliche Tätigkeiten überwiegend im Sitzen, ohne Schichtdienst, ohne häufiges Bücken und ohne erhöhten Zeitdruck mindestens sechs Stunden täglich verrichten.

Die im Reha-Bericht genannten Pausen und die berichteten Verschlechterungen am Folgetag stehen dieser Beurteilung nach Auffassung unseres ärztlichen Dienstes nicht entgegen. Bei der Untersuchung am 10. Juni 2026 waren ein geordnetes Gespräch von 62 Minuten und eine Gehstrecke innerhalb des Dienstgebäudes möglich. Synkopen mit Bewusstseinsverlust sind nicht belegt.

3. Berufliche Tätigkeit

Auf Ihre bisherige Tätigkeit im Zentral-OP kommt es für die beantragte Rente nicht allein an. Maßgeblich ist Ihre Einsatzfähigkeit unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts. Eine konkrete Verweisungstätigkeit wird nicht benannt.

4. Versicherungsrechtliche Voraussetzungen

Die allgemeine Wartezeit und die erforderlichen Pflichtbeiträge wären nach dem Versicherungsverlauf erfüllt. Da die medizinischen Voraussetzungen nicht vorliegen, ergibt sich hieraus kein Leistungsanspruch.

5. Rechtsbehelf

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Deutschen Rentenversicherung Bund einzulegen. Eine Begründung kann nachgereicht werden.

Mit freundlichen Grüßen

Miriam Kästner

Sachbearbeiterin Leistungsabteilung 7 · maschinell unterstützt erstellt und gültig ohne Unterschrift

Datei

Office-Dokument: 04_widerspruch_entwurf_2026-07-01.docx

Rentenberatung Frings

Hohenzollernring 57 · 50672 Köln

Telefon 0221 29917-0 · Telefax 0221 29917-29 · post@rentenberatung-frings.example

Rentenberaterin Jana Frings · Registriert im Rechtsdienstleistungsregister

WIDERSPRUCH

Rentenberatung Frings · Hohenzollernring 57 · 50672 Köln

Deutsche Rentenversicherung Bund

Leistungsabteilung 7

Ruhrstraße 2

10709 Berlin

Datum

1. Juli 2026

Aktenzeichen

RF-26-204 · VSNR 53 170885 R 214

Bearbeitung

Jana Frings

Widerspruch gegen den Bescheid vom 22. Juni 2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

1. Widerspruch

Gegen den am 24. Juni 2026 zugegangenen Bescheid vom 22. Juni 2026 legen wir namens und in Vollmacht von Frau Saskia Renneberg Widerspruch ein. Beantragt wird zunächst vollständige Akteneinsicht einschließlich der sozialmedizinischen Stellungnahme vom 15. Juni 2026 und der Dokumentation der Untersuchung vom 10. Juni 2026.

2. Tatsächliche Belastbarkeit

Der Bescheid leitet aus einem 62-minütigen Gespräch und einem kurzen Weg im Dienstgebäude eine sechsstündige tägliche Leistungsfähigkeit ab. Nicht erkennbar berücksichtigt sind die nach Belastung auftretenden Einbrüche, die notwendige Liegezeit und die fehlende Wiederholbarkeit an fünf Arbeitstagen. Der Reha-Bericht dokumentiert an zwölf Tagen reduzierte Programme und einen zweitägigen Einbruch nach einer 75-minütigen Einheit.

3. Zusammenschau der Befunde

POTS, Fatigue, kognitive Verlangsamung und Belastungsintoleranz dürfen nicht isoliert bewertet werden. Entscheidend ist, ob Arbeitswege, Anwesenheit, Konzentrationsblöcke und betriebsübliche Pausen zuverlässig eingehalten werden können. Der abgebrochene Arbeitsplatzversuch im OP-Büro und das Belastungstagebuch werden nachgereicht.

4. Weitere Ermittlungen

Nach Akteneinsicht soll geprüft werden, ob eine ergänzende kardiologische Untersuchung, eine funktionelle Belastungserprobung über mehrere Tage und eine Arbeitgeberauskunft erforderlich sind. Die Begründung bleibt bis vier Wochen nach vollständiger Akteneinsicht vorbehalten.

Bitte bestätigen Sie den Eingang und übersenden Sie die elektronische Verwaltungsakte in einem lesbaren Format.

Jana Frings

Rentenberaterin

Datei

Office-Dokument: 05_arbeitgeber_arbeitsplatzversuch_2026-06-04.docx

Kliniken der Stadt Köln gGmbH

Ostmerheimer Straße 200 · 51109 Köln

Personalservice · Telefon 0221 8907-0 · personal@kliniken-koeln.example

Geschäftsführung: Petra Hagedorn · Amtsgericht Köln HRB 29233

ARBEITGEBERBESCHEINIGUNG

Kliniken der Stadt Köln gGmbH · Ostmerheimer Straße 200 · 51109 Köln

Frau Saskia Renneberg

zur Vorlage bei der Deutschen Rentenversicherung

Datum

4. Juni 2026

Aktenzeichen

PS-70418 / Mertens

Bearbeitung

Ralf Mertens · Lea Schöning

Dokumentation des betrieblichen Arbeitsplatzversuchs

Sehr geehrte Frau Renneberg,

1. Rahmen

Vom 4. Mai bis 29. Mai 2026 wurde außerhalb einer förmlichen Wiedereingliederung ein befristeter Arbeitsplatzversuch im Verwaltungsbereich des Zentral-OP durchgeführt. Vorgesehen waren montags, mittwochs und freitags jeweils zwei Stunden zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr. Aufgaben waren Materiallisten, Ablage, OP-Dokumentation ohne Patientenkontakt und telefonfreie Datenpflege.

2. Tatsächlicher Verlauf

Datum	Anwesenheit	Beobachtung
04.05.2026	09:05 bis 10:18 Uhr	Abbruch wegen Herzrasen und Schwindel nach Weg vom Parkplatz
06.05.2026	09:02 bis 10:47 Uhr	zwei Arbeitsblöcke zu je 30 Minuten, anschließend Ruheraum
11.05.2026	09:10 bis 10:01 Uhr	Lärm durch Materiallieferung; Heimfahrt durch Ehemann
15.05.2026	nicht erschienen	telefonische Meldung eines Belastungseinbruchs nach Arzttermin
20.05.2026	09:00 bis 11:06 Uhr	längster Versuch, vier Pausen, am Folgetag krankheitsbedingt ausgefallen
27.05.2026	09:04 bis 09:46 Uhr	Abbruch nach ungeplanter Rückfrage und Weg zum Archiv

3. Organisatorische Einschätzung

Frau Renneberg war fachlich sicher und arbeitete sorgfältig, wenn sie anwesend war. Die erforderlichen spontanen Pausen und die kurzfristigen Ausfälle lassen sich im OP-Büro dauerhaft nicht verlässlich abdecken. Ein vollständig reizarmes Einzelbüro mit frei wählbaren Arbeitszeiten steht im Betrieb nicht zur Verfügung.

4. Ende des Versuchs

Der Versuch wurde im Gespräch am 29. Mai 2026 einvernehmlich beendet. Diese Bescheinigung trifft keine medizinische oder rentenrechtliche Bewertung. Sie gibt ausschließlich den beobachteten Verlauf und die betrieblichen Rahmenbedingungen wieder.

Mit freundlichen Grüßen

Ralf Mertens · Lea Schöning

Kliniken der Stadt Köln gGmbH

Ostmerheimer Straße 200 · 51109 Köln

Personalservice · Telefon 0221 8907-0 · personal@kliniken-koeln.example

Geschäftsführung: Petra Hagedorn · Amtsgericht Köln HRB 29233

Leitung Zentral-OP · Personalreferentin

Datei

Office-Dokument: 06_ehemann_alltagsprotokoll_2026-06-30.docx

Privater Bericht von Tobias Renneberg

Aachener Straße 418 · 50933 Köln

Telefon 0221 788419 · Bezug: Saskia Renneberg, geboren 17. August 1985

Erstellt aus täglichen Kalendernotizen und Pulsuhr-Aufzeichnungen

PERSÖNLICHE ERKLÄRUNG

Privater Bericht von Tobias Renneberg · Aachener Straße 418 · 50933 Köln

An die Deutsche Rentenversicherung Bund
über Rentenberatung Frings

Datum

30. Juni 2026

Aktenzeichen

VSNR 53 170885 R 214

Bearbeitung

Tobias Renneberg

Beobachtungen zur Belastbarkeit meiner Ehefrau Saskia Renneberg

Sehr geehrte Damen und Herren,

1. Haushalt

Meine Frau kann morgens an guten Tagen selbst duschen und sich anziehen. Danach legt sie sich häufig für 30 bis 60 Minuten hin. Kochen gelingt, wenn Zutaten vorbereitet sind und sie sitzen kann. Einkäufe, Wäschekörbe, Staubsaugen und längere Wege übernehme ich. Unsere Tochter Nele bringt an schlechten Tagen Getränke ins Schlafzimmer.

2. Konkrete Tage im Juni

Am 3. Juni fuhren wir zur kardiologischen Praxis. Der gesamte Weg einschließlich Warten dauerte 78 Minuten. Saskia lag danach bis 16:20 Uhr im abgedunkelten Zimmer und sagte den Elternabend am nächsten Tag ab. Am 10. Juni brachte ich sie zur Untersuchung der Rentenversicherung. Sie konnte das Gespräch führen, schlief auf der Rückfahrt ein und blieb am Folgetag überwiegend im Bett.

Am 19. Juni ging sie 25 Minuten mit mir in den Supermarkt. Der Puls stieg laut Uhr auf 129. Sie setzte sich zweimal auf eine Getränkekiste und ruhte zu Hause etwa sechs Stunden. Am 24. Juni beantwortete sie vormittags E-Mails für insgesamt 52 Minuten in drei Blöcken; danach verwechselte sie beim Kochen Salz und Zucker und brach ab.

3. Schwankungen

Es gibt einzelne Stunden, in denen Saskia normal wirkt, lacht und konzentriert spricht. Diese Stunden lassen sich nicht planen. Wird an einem guten Tag zu viel erledigt, folgt häufig ein deutlich schlechterer Tag. Wir notieren seit Mai Uhrzeiten und Belastungen, weil kurze Termine nach außen einen falschen Eindruck vermitteln können.

4. Bestätigung

Ich habe den Bericht nach bestem Wissen selbst verfasst. Die erwähnten Pulsdaten stammen aus der Uhr meiner Frau; die zugrunde liegenden Bildschirmfotos liegen der Familie vor. Mir ist bewusst, dass ich als Ehemann nicht neutral bin. Die geschilderten Abläufe lassen sich teilweise durch Arzttermine, Kalender und Nachrichten an den Arbeitgeber nachvollziehen.

Mit freundlichen Grüßen

Tobias Renneberg

Ehemann der Versicherten

Datei

Office-Dokument: 99_arbeitsstand_und_offene_punkte_2026-07-06.docx

AKTENVERMERK

Datum

6. Juli 2026

Aktenzeichen

RF-26-204 / jf

Bearbeitung

Jana Frings

Arbeitsstand Renneberg / Widerspruch Erwerbsminderungsrente

1. Frist

Der Bescheid ging nach Umschlag und E-Mail der Mandantin am 24. Juni 2026 zu. Der Widerspruch wurde am 1. Juli 2026 per Einschreiben und Telefax abgesandt. Faxprotokoll ist vorhanden; die schriftliche Eingangsbestätigung steht aus.

2. Verwaltungsakte

Angefordert sind die sozialmedizinische Stellungnahme vom 15. Juni 2026, Untersuchungsbogen vom 10. Juni 2026, interne Auswertung des Reha-Berichts und sämtliche Befundanforderungen. Wiedervorlage am 12. Juli 2026; bei fehlender Reaktion telefonische Nachfrage beim Servicezentrum.

3. Beweisunterlagen

Der Reha-Bericht, der Kipptischbefund und die Arbeitgeberbescheinigung liegen vor. Es fehlen die betriebliche Zeiterfassung, die vollständigen Therapieteilnahmelisten der Reha und die Bildschirmfotos der Pulsuhr. Der Ehemann soll die Originalnotizen nicht nachträglich glätten, sondern datiert im vorhandenen Zustand vorlegen.

4. Nächster Arbeitsschritt

Nach Akteneinsicht wird eine Befund- und Widerspruchsmatrix erstellt: beobachtete Leistungsdauer, Pausenbedarf, Folgetag-Ausfall, Wegefähigkeit und betriebliche Verwertbarkeit. Diagnosen werden nur mit funktionellen Auswirkungen verbunden. Eine ergänzende Untersuchung wird erst nach Sichtung des DRV-Gutachtens beantragt.

Jana Frings

Rentenberaterin

Datei

PDF-Anhang: 07_kipptischprotokoll_kurzbefund_2026-05-21.pdf

Universitätsklinikum Köln

Universitätsklinikum Köln · Kerpener Straße 62 · 50937 Köln
Klinik für Kardiologie und Postinfektiöse Erkrankungen · Telefon 0221 478-0
Ärztliche Leitung: Prof. Dr. Silke Bartram

Frau Saskia Renneberg
Aachener Straße 418 · 50933 Köln

Datum: 21. Mai 2026 Aktenzeichen: KAR-POTS-26-1842

Kipptischuntersuchung und Schellong-Protokoll

1. Fragestellung

Abklärung rezidivierender Präsynkopen, orthostatischer Tachykardie und belastungsabhängiger Beschwerden bei postinfektiösem Syndrom. Ivabradin wurde nach ärztlicher Rücksprache 24 Stunden vor der Untersuchung pausiert.

2. Messwerte

Zeitpunkt	Lage	Blutdruck mmHg	Herzfrequenz pro Minute	Beschwerden
08:42	liegend 10 Minuten	118/74	78	keine
08:45	70 Grad, Minute 3	112/72	108	Herzklopfen
08:48	70 Grad, Minute 6	104/68	128	Schwindel, Wärmegefühl
08:50	70 Grad, Minute 8	96/64	142	Präsynkope, Sehstörung
08:51	wieder liegend	102/66	116	Übelkeit
09:02	Erholung liegend	114/72	86	deutlich gebessert

3. Befund

Herzfrequenzanstieg um 64 Schläge pro Minute innerhalb von acht Minuten bei deutlicher Beschwerdeprovokation. Kein vollständiger Bewusstseinsverlust. Der Test wurde aus Sicherheitsgründen abgebrochen. Im Ruhe-EKG Sinusrhythmus ohne akute Ischämiezeichen.

4. Weiteres Vorgehen

Empfohlen werden ausreichende Flüssigkeits- und Salzaufnahme nach ärztlicher Abstimmung, konsequente Kompressionsversorgung, vorsichtige Belastungssteuerung und kardiologische Verlaufskontrolle. Eine Aussage zur täglichen Erwerbsfähigkeit ist mit diesem Einzelbefund nicht verbunden.

Dr. med. Henrike Laux
Oberärztin Kardiologie